Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento:

Constipação intestinal

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:
Constipação intestinal

Aula com base na aula da Dra PATRÍCIA BOECHAT GOMES

SUPREMA

Objetivos da aula

- Reconhecer e diagnosticar corretamente uma criança portadora de constipação intestinal crônica funcional (CICF).
- Conduzir adequadamente a investigação e acompanhamento do paciente com CICF.
- Identificar e atuar nas medidas de prevenção.

SUPREMA

Importância

- Prevalência no Brasil:14,7 a 38,4%

  Morais *et al*., 2000
- Influência na qualidade de vida, associação com problemas psicológicos Youssef *et al.,* 2005
- Envolvimento de toda a família

  Reid *et al.,* 2006
- Complicações NASPGHAN, 2014

SUPREMA

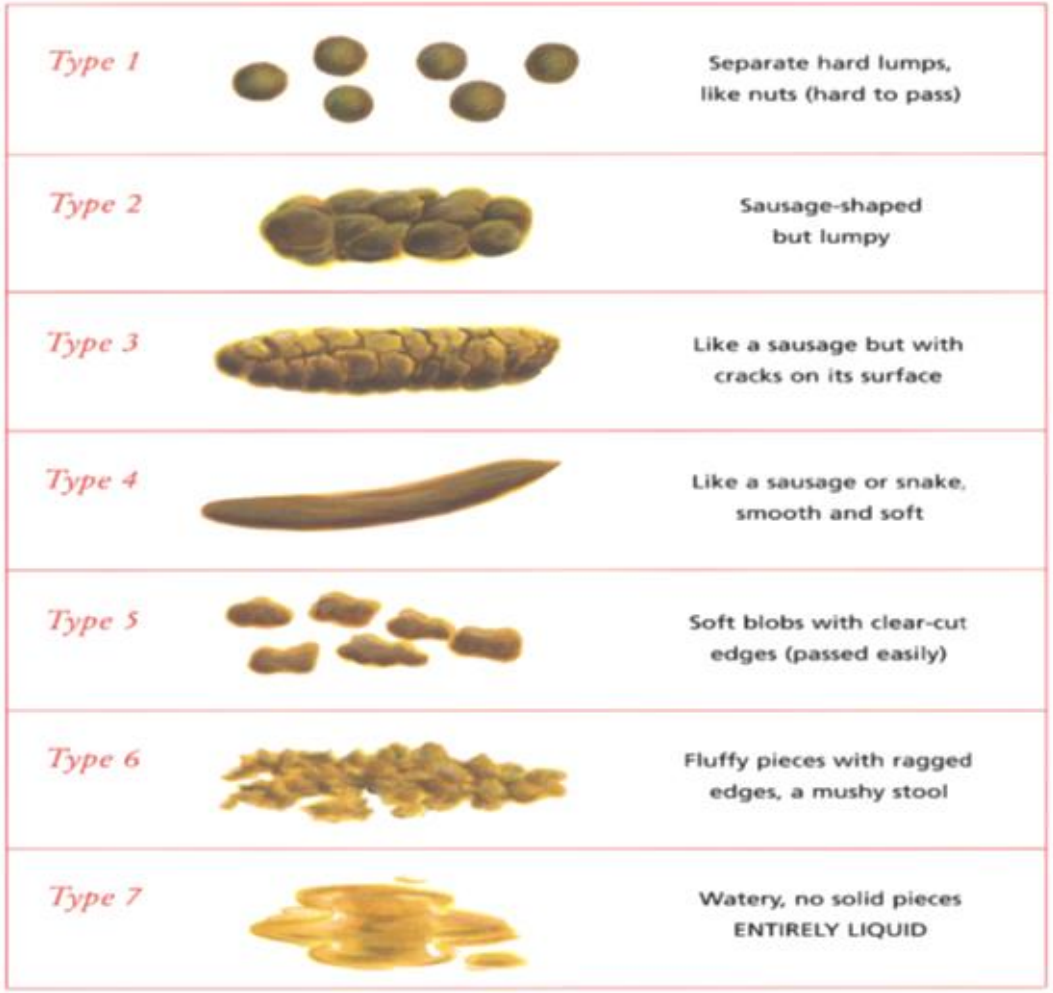
Definição: ROMA IV

- **Pelo menos 2 dos critérios, por 1 mês**
  - **2 ou menos evacuações por semana**
  - **Pelo menos 1 episódio de incontinência fecal por semana**
  - **Postura retentiva**
  - **Dor abdominal/Dor ao evacuar(“movimentos intestinais dolorosos”)**
  - **Massa fecal no reto**
  - **Fezes calibrosas que entopem o vaso**

Rasquin *et al*.

SUPREMA

THE BRISTOL STOOL FORM SCALE



Reproduced by kind permission of Dr KW Heaton, Reader in Medicine at the University of Bristol.
©2000 Produced by Norgine Limited, manufacturer of Movicol®

Candy *et al.*, 2005

SUPREMA

Investigação Diagnóstica

Anamnese

- Época de aparecimento (desmame/fralda/escola)
- Alimentação
- Fatores psicológicos associados
- Retirada das fraldas/ hábitos de toalete
- Tratamentos anteriores
- Doenças associadas

SUPREMA

Investigação Diagnóstica

Exame físico

- Completo
- Toque retal
- Região dorsal (tufo de pelos, dimple sacral, desvio de prega glútea, hemangioma)
- Inspeção anal
- Palpação abdominal

SUPREMA



Foto aula Dra Patricia Boechat

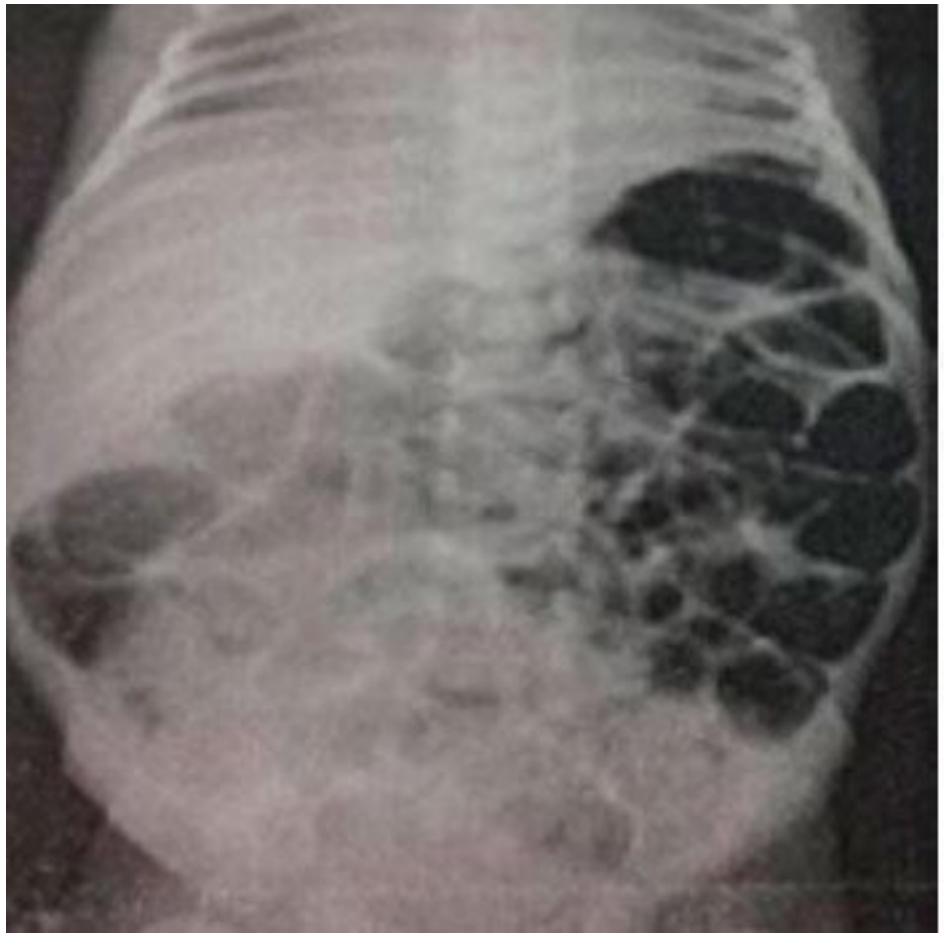


Foto : aulaPediatria UniRio

Investigação Diagnóstica - Exames Complementares

- Desnecessários na maioria dos casos de constipação funcional
- Na suspeita de distúrbios orgânicos
  - Radiografia simples de abdome sem preparo
  - Enema opaco (suspeitas de megacolon)
  - Manometria anorretal
  - Biópsia retal (displasia neuronal intestinal ou outras anormalidades mioentéricas)

SUPREMA





Fotos : Google

SUPREMA

Manejo da constipação

Etapas a serem seguidas

- Desimpactação (enema oral ou retal)
- Uso prolongado de laxativos
- Reeducação de hábitos de toalete

SUPREMA

Opções terapêuticas

- Lubrificantes
  - Óleo mineral: contra-indicado em lactentes, neuropatas e regurgitadores (1-3 ml/kg/dia)

- Agentes osmóticos
  - Lactulose: dissacarídeo sintético. Pode levar a tolerância em longo prazo (1-3 ml/kg/dia)
  - Hidróxido de magnésio: Uso não recomendado em comprometimento renal (1-3 ml/kg/dia)

→ Sabor e volume comprometem adesão

✓Polietilenoglicol

- Agente osmótico, inodoro e insípido

  Loening-Baucke *et al*., 2004; Gremse *et al*., 2002; Candy *et al*., 2006; Pashankar *et al*., 2001,2003

- Apresentação sob a forma de pó que pode ser misturado em vários líquidos

  Pashankar *et al*., 2001,2002,2003; Loening-Baucke *et al*., 2004

- Pouco absorvido pelo organismo

  Rendeli *et al*., 2006; Gremse *et al.,* 2002; Pashankar *et al*., 2003,2004; Loening-Baucke *et al*., 2004; Kinserkiv *et al*., 2004; Voskuijl *et al*., 2004

SUPREMA

✓Polietilenoglicol

- Pesos moleculares diferentes: 3350 e **4000**

Candy *et al*., 2009; Arora *et al*., 2005

- Com ou **sem** adição de eletrólitos

Dupont *et al*., 2006

- Doses médias
  - 4000: 0,5g/kg/dia
  - 3350: 0,8g/kg/dia

Pashankar *et al*., 2001

- Medicamento de primeira linha

NASPGHAN,2014

SUPREMA

Hábitos alimentares:

- Ingestão adequada de fibras



- Ingestão adequada de líquidos



- Diminuir ao máximo alimentos ultraprocessados

SUPREMA

Hábitos de toalete:



- Estimular utilização do vaso sanitário após as refeições (5 min)
- Pés apoiados no momento da evacuação (banquinho)
- Concentração

Incentivar atividade física

SUPREMA

Educação/orientação familiar

- Explicar que incontinência é involuntária,
- Argumentar que constipação precisa ser tratada, pois causa dificuldades escolares e sociais.
- Em todas as consultas: encorajar os pais a manter atitude positiva e de suporte em todos os aspectos do tratamento
- Esclarecer sobre complicações a curto e longo prazo

SUPREMA

Dificuldades

- Tratamento difícil

  NASPGHAN, 2014

- Grande recorrência de sintomas

  Candy *et al*., 2003

- Participação ativa da família

Prevenção

- Aleitamento materno
- Consumo de alimentos sólidos
- Atividade física
- Ingestão adequada de líquidos
- Retirada das fraldas de maneira tranquila







SUPREMA

Conclusão

- A constipação é um quadro frequente em pediatria muitas vezes subdiagnosticado
- A necessidade de exames é infrequente.
- O tratamento é difícil com grandes chances de recorrência: envolve mudanças de hábito alimentares além de envolvimento da família.
- A droga de escolha hoje é o polietilenoglicol.

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.

SUPREMA